

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia en el apartado que mejor encaje. Luego repasa las reglas destacadas de la sección correspondiente. Por último, verifica la literalidad en la norma: contrasta el enunciado con los artículos indicados en cada bloque (mismo número y contenido).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, principios y orientación del sistema valenciano de salud	1-3	Define el objeto de la ley (protección de la salud) y el enfoque del sistema: promoción, prevención y asistencia; evaluación, transparencia y atención a desigualdades.
Definiciones clave, cartera y accesibilidad e igualdad	4,9-11.ter	Aporta conceptos (determinantes, desigualdades, evaluación del impacto, etc.) y regula cartera de servicios, accesibilidad total y eliminación de discriminaciones.
Planificación territorial y estructura del Sistema Valenciano de Salud	12-16	Ordena el Plan de Salud, departamentos y mapa sanitario, y regula la organización de personal e instrumentos como el SIP.
Salud pública: vigilancia, información, promoción y prevención	21-22,23-31,33,34,35,36-39	Estructura salud pública (funciones esenciales, vigilancia, sistema de información), y define promoción y prevención; coordina con atención asistencial.
Derechos y garantías de pacientes y usuarios/os	40-53	Garantiza derechos (información, confidencialidad, consentimiento, historia clínica, segunda opinión, acompañamiento) y deberes del paciente.
Atención a colectivos: salud mental y otros ámbitos específicos	4.bis-4.sexies,54-60,58-59.8	Regula salud mental (modelo comunitario, profesionales, atención integral) y la atención en infancia/adolescencia, discapacidad y salud escolar; incluye salud sexual y reproductiva.
Trastornos adictivos: prevención, tratamientos, publicidad y medidas	61-77	Ordena el plan estratégico, prevención y tratamientos voluntarios con excepciones; regula publicidad y consumo de alcohol/drogas y financiación.
Docencia, investigación, autoridad sanitaria y régimen de intervención	79-83	Asegura docencia e investigación, define autoridad sanitaria y agentes, y somete actividades a intervención y autocontrol.
Inspección, medidas especiales, infracciones y sanciones	85-98,99-103,100-106,108-115	Establece inspección, medidas especiales, tipificación (leves/graves/muy graves) y prescripción, procedimiento sancionador y reglas de resolución.

3. Protección de la salud: enfoque del sistema y planificación (arts. 1-3,12,14)

Finalidad y principios operativos

- La ley garantiza el derecho a la protección de la salud en la Comunitat Valenciana mediante promoción, prevención y ordenación de la atención.
- Las políticas de salud deben evaluarse, ser transparentes y ofrecer información clara, sencilla y accesible.

Planificación y ordenación territorial

- El Plan de Salud es el instrumento estratégico: valora necesidades y recursos, fija objetivos y programas, e incluye evaluación e indicadores.
- El mapa sanitario ordena territorio en departamentos y zonas básicas; su actualización se aprueba reglamentariamente.

4. Salud pública y prevención: información, vigilancia, promoción e impacto en salud (arts. 21-22,23-27,30-31,36-39)

Vigilancia e información para fundamentar actuaciones

- La vigilancia recoge, analiza, interpreta y difunde información para fundamentar actuaciones; monitoriza datos con desagregación territorial viable.
- El Sistema de Información en Salud Pública integra estadísticas/ registros/encuestas y asegura información comprensible y accesible.

Promoción, prevención e integración con lo asistencial

- La promoción permite incrementar control sobre determinantes; requiere políticas públicas saludables y enfoque intersectorial.
- La prevención reduce incidencia/prevalencia y sus consecuencias con acciones como vacunación, cribado, diagnóstico y tratamiento precoz.

5. Pacientes y usuarios/os: derechos, consentimiento y documentación clínica (arts. 40-47,49-53)

Garantías básicas en la atención

- Se reconoce el respeto a dignidad, autonomía de la voluntad, intimidad e igualdad efectiva en acceso a servicios.
- Confidencialidad de datos de salud y preservación de la intimidad corporal respecto a otras personas.

Información, consentimiento y herramientas documentales

- Toda actuación asistencial requiere consentimiento libre y voluntario tras información previa; verbal por regla general y escrito en supuestos tasados.
- Historia clínica única por paciente; derecho de acceso y copia, e informe de alta con diagnóstico y recomendaciones.

6. Salud mental y colectivos: modelo comunitario y atención integral (arts. 4.4,4.6,56-59)

Principios de atención en salud mental

- La atención se realiza principalmente en ámbito comunitario, potenciando recursos e intervención temprana sin estigmatización.
- Se respetan, promueven y defienden derechos; cultura de servicios libres de coerción y dignidad como eje.

Organización y apoyo profesional

- La conselleria debe coordinar un marco comunitario integral con continuidad de cuidados, recuperación e inclusión.
- Implementación de profesionales de salud mental con, al menos, un psicólogo clínico en cada centro de salud de atención primaria.

7. Trastornos adictivos: prevención, tratamientos y límites a la publicidad (arts. 61-66,69,73-76)

Prevención y planificación estratégica

- El Plan Estratégico sobre Trastornos Adictivos ordena recursos, objetivos e indicadores de evaluación.
- La prevención se dirige especialmente a menores, jóvenes y familias de riesgo, con programas de reducción de riesgos.

Tratamientos y regulación de comunicaciones/comercio

- Los tratamientos tienen carácter voluntario, con posibilidad de internamiento no voluntario por trastorno psíquico según legislación civil.
- Se prohíbe publicidad y promoción de alcohol dirigida a menores; también venta/suministro en centros y franjas horarias según reglas.

8. Inspección y sanciones: intervención, tipificación y procedimiento (arts. 81,82-87,89-98,99-115)

Autoridad, inspección y medidas especiales

- La actuación inspectora busca asegurar asistencia equitativa y calidad, y tutela el cumplimiento de normativa de salud pública.
- Con riesgo excepcional y negativa repercusión, pueden adoptarse medidas especiales cautelares o definitivas mediante procedimiento.

Infracciones, sanciones y plazos de prescripción

- Infracciones se califican como leves, graves y muy graves; se determinan por criterios como riesgo, intencionalidad y reincidencia.
- Prescripción: infracciones leves 1 año, graves 3 años, muy graves 5 años; sanciones con plazos según el régimen aplicable.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
El Plan de Salud: remisión a Les Corts tras aprobación	30 días	12.5
Información previa al consentimiento (regla general)	al menos 24 horas antes	43.9
Procedimiento de sanciones: plazo máximo para dictar y notificar resolución	9 meses	98.3
Procedimiento sancionador: plazo máximo para dictar y notificar resolución (simplificado)	6 meses	98.3
Infracciones: prescripción (regla general)	1 año (leves), 3 años (graves), 5 años (muy graves)	92.3
Infracciones: prescripción (inicio e interrupción)	desde el día de comisión; interrumpe con inicio del procedimiento sancionador (y reinicia si paralización > 1 mes)	92.4
Medidas especiales en salud pública: plazo para resolver y notificar	6 meses	91
Sanciones en capítulo de farmacia: prescripción	1 año (leves), 2 años (graves), 3 años (muy graves)	115.1
Sanciones en capítulo de farmacia: prescripción de sanción (regla general)	desde ejecutable/desde fin plazo recurso	115.3

10. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.